

Łokieć tenisisty – przyczyny, objawy, metody leczenia

AUTORZY PROJEKTU:

KATARZYNA DYŚ 72533

ERNEST KURDZIEL 72714

MATEUSZ KRASOŃ 72329

OPIS PROBLEMU FUNKCJONALNEGO

Łokieć tenisisty (łac. *epicondylitis lateralis humeri*) to w rzeczywistości nie stan zapalny, lecz **entezopatia** – choroba zwyrodnieniowo-przeciążeniowa przyczepu bliższego ścięgien mięśni prostowników nadgarstka i palców. Proces patologiczny dotyczy głównie mięśnia prostownika promieniowego krótkiego nadgarstka. Dochodzi w nim do mikrourazów, dezorganizacji włókien kolagenowych oraz neowaskularyzacji, co skutkuje zaburzeniem funkcji chwytnej ręki.

PRZYCZYNY I OBJAWY KLINICZNE

Etiologia (Przyczyny):

- Powtarzalne ruchy prostowania nadgarstka i supinacji przedramienia.
- Długotrwała praca biurowa (pisanie na klawiaturze, operowanie myszką).
- Aktywność sportowa (tenis, squash) o błędnej biomechanice.
- Prace manualne (stolarze, mechanicy, stomatolodzy).

Obraz kliniczny (Objawy):

- Ostry, kłujący ból w okolicy nadkłykcia bocznego kości ramiennej.
- Promieniowanie bólu wzdłuż grzbietowej strony przedramienia.
- Spadek siły uścisku dłoni (np. ból przy witaniu się, odkręcaniu stoika).
- Dodatkowo testy kliniczne (Test Thomsona, Test Cozena, Test Milla).

METODY LECZENIA

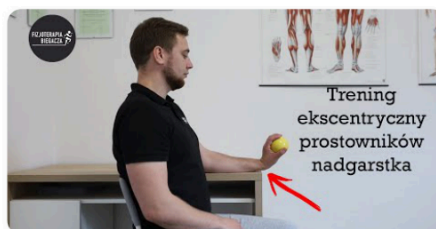
FIZJOTERAPEUTYCZNEGO

Ze względu na degeneracyjny charakter schorzenia, terapia skupia się na stymulacji fibroblastycznej i remodelingu tkanki, a nie na leczeniu przeciwzapalnym. Złotym standardem fizjoterapii łokcia tenisisty jest połączenie kinezyterapii z celowaną terapią manualną i fizykoterapią.

1. Kinezyterapia (Trening ekscentryczny): Fundament leczenia. Polega na wolnym, kontrolowanym opuszczaniu ciężaru (rozciąganie napiętego mięśnia prostownika). Trening ten stymuluje prawidłową syntezę kolagenu typu I, poprawiając wytrzymałość mechaniczną ścięgna.

2. Terapia manualna: Zastosowanie **Głębokiego Masażu Poprzecznego** wg Cyriaxa na przyczepie mięśnia, co zapobiega zrostom w obrębie blizny i wywołuje przekrwienie sprzyjające gojeniu. Pomocna jest także mobilizacja stawu ramienno-promieniowego.

3. Fizykoterapia i Taping: Wysoką skuteczność (udowodnioną klinicznie) wykazuje **Zewnątrzustrojowa Fala Uderzeniowa (ESWT)**. Wspomagająco stosuje się kinesiotaping odciążający oraz w fazie ostrej – krioterapię.



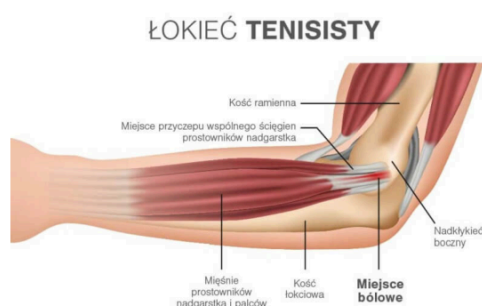
Rycina 2. Faza ekscentryczna treningu prostowników nadgarstka.

Źródło: youtube.com/watch?v=VFq55pceMPI (Fizjoterapia Biegacza)



Rycina 3. Zabieg z użyciem fali uderzeniowej.

Źródło: youtube.com/watch?v=_vAxkEz7Gxk



Rycina 1. Lokalizacja zmian degeneracyjnych ścięgna m. prostownika promieniowego krótkiego nadgarstka.

Źródło: rehasport.pl/lokiec/lokiec-tenisisty,5221,n,4324

LITERATURA I ŹRÓDŁA

1. Bac A., Jankowicz-Szymańska A., Liszka H., Wódka K. Diagnostyka narządu ruchu w fizjoterapii. Tom 1. 2022.
2. Kruczyński J. (red.) Wiktora Degi ortopedia i rehabilitacja. 2023.
3. Lucado A.M. i wsp. Lateral Elbow Pain and Muscle Function Impairments. 2022.
4. Karbowski M. i wsp. Management of Lateral Epicondylitis (Tennis Elbow). 2023.
5. Materiały wideo (YouTube). Trening ekscentryczny prostowników nadgarstka; Terapia falą uderzeniową.
6. Rehasport. Łokieć Tenisisty. (www.rehasport.pl)